

Prescrição PS Fast

Receitas prontas para PS / APS. Lembrar: alergias · AINE → rim · corticoide → HAS e DM. Doses = ponto de partida adulto; validar peso, função renal/hepática, gestação e protocolo local.

■ Geral / Crítico

Acidente botrópico (jararaca) · CID T63

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Soro antibotrópico (5mg/ml):
Leve: 2-4 amp EV
Moderado: 4-8 amp EV
Grave: 12 amp EV.
Se infecção secundária: Cloranfenicol 50-100 mg/kg/dia V0/EV 6/6 horas.
Dipirona 1g EV 6/6 horas.

■ Manter diurese 30-40 ml/hora; elevação do membro. Complicações: fasciotomia / desbridamento / drenagem.

Acidente escorpiónico · CID T63

■ PS / Sala — Moderado / grave

Moderado: monitorização; soro antiescorpiónico (5ml) 3 amp EV (ou antiaracnídico 3 amp EV); observação 24h.
Grave: soro antiescorpiónico (5ml) 6 amp EV (ou antiaracnídico 6 amp EV); internação.

■ Leve: infiltração de anestésico sem vasoconstrictor, observação 4h, compressa morna. Limpar com água e sabão.

Acidente por aranha marrom · CID T63

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Leve-moderado: Prednisona 20mg – 2 comprimidos pela manhã por 5 dias.
Grave: 5 amp SAAr EV (em até 36h da picada) + Prednisona 20mg 2 cp/manhã por 5 dias.
Muito grave: 10 amp SAAr EV + Prednisona 20mg 2 cp/manhã por 5-7 dias.

Anafilaxia · CID T78

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Adrenalina (1mg/ml): 0,3-0,5 mg IM – repetir 5/5 min por mais 2x se necessário.
Sala de emergência. MOV. Dieta zero. Ringer lactato 500ml EV.
Hidrocortisona (100mg/frasco): 300mg + SF 0,9% 10 ml.
Se broncoespasmo: nebulização Salbutamol (5mg/ml) 10-20 gotas + 3ml SF 0,9%.

■ PS / Sala — Refratariedade

Adrenalina 0,1ml + 9ml SF EV em bolus.
Adrenalina 10 amp + 90ml SG5% em BIC – começar 4ml/hora em acesso central.

Dengue / Arbovirose · CID A90

■ Sinais de alarme (surgem na DEFERVESCÊNCIA, 3º-6º dia): dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, letargia/irritabilidade, hipotensão postural/lipotimia, hepatomegalia dolorosa, Ht subindo com plaquetas caindo.

■ PS / Sala — Grupo C/D

Hemograma, albumina, transaminases, PCR. Se necessário: Rx tórax, USG abdominal.
10ml/kg SF0,9% EV. Reavaliar. Mais 10ml/kg SF0,9% EV.

■ Casa — Sem alarme

Soro de reidratação oral – 4 envelopes
Diluir 1 envelope em 1 litro de água e beber durante o dia. Beber mais 3 litros de outros líquidos.
Dipirona 1g
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor ou febre.
OU Paracetamol 500mg
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor ou febre.
Desloratadina 5mg
Tomar 1 comprimido 1x ao dia se coceira.
Dramin B6
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas se náusea, vômito ou tontura.
OU Ondansetrona 8mg – 1 comprimido de 8/8h se náusea/vômito por 5 dias.

■ Colher NS1 em até 5 dias de sintomas (de preferência no 3º). EVITAR AINE e AAS (risco de sangramento) — usar dipirona/paracetamol. Paciente em uso de AAS: hemograma diário; suspender se plaquetas <30.000. Repouso e aumento de ingestão de líquidos.

Dor de dente · CID K08.8

Anamnese

PACIENTE REFERE DOR DE DENTE HÁ [X] DIA(S). Nega febre ou outros sintomas sistêmicos. Informo que não há de

Exame físico

Bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Sem edema, hiperemia ou alterações visíveis. Cavidade oral sem secreção purulenta evidente.

■ Casa — Prescrição — Casa

Dipirona 500mg – 20 comprimidos
Tomar via oral 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.
Diclofenaco 50mg – 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 5 dias.

■ Orientar retorno se febre, edema local, trismo ou piora da dor.

Febre maculosa · CID A77

■ Casa — Prescrição — Casa

Doxiciclina 100mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 7 dias (ou até 7 dias após parar a febre).
Dipirona 500mg
Tomar 1 comprimido de 6/6h se dor ou febre.
Dramin B6
Tomar 1 comprimido de 8/8h se náusea ou vômito.

■ Internação — Se internação

SF 0,9% 30ml/kg EV em 24h.
Doxiciclina 100mg EV de 12/12 horas (manter por 3 dias após término da febre).
Dipirona 1g EV 4/4h se dor ou febre.
Bromoprida 10mg/2ml EV de 8/8h se náusea ou vômito.

■ Solicitar hemograma, Na, K, creatinina, TGP, TGO.

Intoxicação exógena · CID Y19.9

■ PS / Sala — Descontaminação / antídotos

Carvão ativado 1g/kg (máx 50g) – até 2 horas da ingestão, VO ou SNE. Manter: 50g 4/4 horas.
AAS/tricíclicos/fenobarbital: Bicarbonato de sódio 1-2 mEq/kg (ampola 8,4%, 1ml=1mEq) EV bolus; após 150ml
Organofosforados/carbamatos: Atropina 2mg EV a cada 5 min até sumir roncos.
Opioides: Naloxona 0,4mg EV, repetir a cada 3 min aumentando a dose (0,8/2/4/6).
Benzodiazepínicos: Flumazenil 0,1mg EV bolus.
Cocaína/anfetamina/crack: Diazepam EV.
Paracetamol: N-acetilcisteína 140mg/kg; manter 17 doses de 70mg/kg 4/4 horas.

■ MOV (O2 se Sat <94%), ABCD, ligar Ceatox 0800 014 8110. Hemograma, EAS, função renal, Na, K, Ca, Mg, gasometria arterial, ECG.

Leptospirose · CID A27

■ Casa — Prescrição — Casa

Doxiciclina 100mg – 14 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 7 dias.
Dipirona 500mg
Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6 horas se dor ou febre.
Bromoprida 10mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas se náusea ou vômito.

■ Hemograma, ureia, creatinina, Na, K, TGO, TGP, bilirrubina, VHS, PCR, Urina I, CPK, sorologia. Repouso, hidratação, evitar aspirina.

Relação sexual desprotegida / Violência sexual (PEP) · CID Z20.2

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Tenofovir/Lamivudina 300mg + 300mg – 1 comprimido ao dia por 28 dias.
Dolutegravir 50mg – 1 comprimido ao dia por 28 dias.
Levonorgestrel 1,5mg (até 72 horas) – 1 comprimido VO.
Penicilina G benzatina 2.400.000 UI IM – 1.200.000 em cada glúteo.
Ceftriaxona 500mg IM.
Azitromicina 500mg – 2 comprimidos VO.
Metronidazol 400mg – 5 comprimidos VO.

■ Teste rápido HIV, sífilis, hepatite B e C. Checar vacina hepatite B. PEP até 72 horas.

Sepse · CID A41

■ PS / Sala — Alta suspeição

Gasometria, lactato e culturas. Antibiótico: ligar CCIH do hospital.
Cristaloide 30ml/kg em 3h — alíquotas de 500ml.
Se necessário: Noradrenalina (1mg/ml) 20ml + 80ml SG 5% EV em BIC (começar 10ml/h).
Dipirona (500mg/ml): 1-2g 6/6h.
Bromoprida (10mg/2ml): 10mg EV 8/8h.
Omeprazol (40mg/ml): 20-40mg EV/VO pela manhã.

■ Suspeita: SOFA e NEWS — hemograma, creatinina, bilirrubina. Ao internar: hemocultura e urocultura.

■ Cabeça / Neuro

Ataque isquêmico transitório · CID G45

■ Casa — ABCD2 <4

AAS 100mg
Tomar 2 comprimidos ao dia.

■ Internação — ABCD2 ≥4

Internação.
AAS 100mg: 2 comprimidos dose de ataque, seguido de 1 comprimido/dia.
Clopidogrel 75mg: 4 comprimidos dose de ataque, seguido de 1 comprimido ao dia (por 21 dias).
Dipirona 1g EV de 4/4 horas. Metoclopramida 10mg EV 8/8 horas. Omeprazol 20-40mg VO/EV pela manhã.

■ ECG, USG cervical, Angio-TC/RNM, eco transtorácico. Calcular ABCD2.

AVC hemorrágico · CID I61 · I62

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Dieta zero. SF 0,9% ou Ringer lactato 20-30 ml/kg/dia.
Dipirona 1g EV de 4/4 horas.
Metoclopramida 10mg EV 8/8 horas.
Omeprazol 20-40mg VO/EV pela manhã.
Crise convulsiva: Difenil-hidantoína (50mg/ml) ataque 15 mg/kg EV; manutenção 100mg EV de 8/8h.
Subaracnoide: Nimodipina 60mg 4/4 horas por 21 dias.

■ Dextro, hemograma, coagulograma, βhCG, ECG, TC crânio sem contraste. Manter PAS=140 (intraparenquimatosa) ou <160 (subaracnoide): Nitroprussiato (25mg/ml) 50mg + 250ml SG5% (=200mcg/ml) iniciar 0,5 mcg/kg/min. Suspender/reverter antiagregantes e anticoagulantes. Internação UTI + neurocirurgia.

AVC isquêmico · CID I63 · I64

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Dieta zero. SF 0,9% ou Ringer lactato 20-30 ml/kg/dia.
Insulina regular 2-4 UI SC (manter glicemia 140-180).
Dipirona 1g EV de 4/4 horas.
Metoclopramida 10mg EV 8/8 horas.
Omeprazol 20-40mg VO/EV pela manhã. O2 se Sat <94%.

■ PS / Sala — Trombólise (<4,5h) — checar contraindicações

Alteplase (50mg/ml) 0,9 mg/kg (máx 90mg): 10% da dose em bolus, restante em infusão lenta em 1 hora — acesso
AAS 100mg: 2 comprimidos ao dia (se trombólise, aguardar 24h para iniciar).
Heparina não fracionada 5000 SC 8/8h OU Enoxaparina 40mg SC 24/24h (se trombólise, aguardar 24h).

■ Dextro, hemograma, coagulograma, βhCG, ECG, TC crânio sem contraste. Controle PA: manter ≤220x120; iniciar trombólise apenas se ≤185x110 (manter <180x110). Nitroprussiato (25mg/ml) 50mg + 250ml SG5% (=200mcg/ml) iniciar 0,5 mcg/kg/min. Internação UTI.

Cefaleia · CID R51

Anamnese

Paciente refere cefaleia há [X]. Nega início súbito da dor, nega pico de intensidade em segundos, nega piora

Exame físico

Bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Neuro: Glasgow 15, sem sinais meníngeos, sem déficits focais.

■ Casa — Prescrição — Casa

Dipirona 500mg — 40 comprimidos
Tomar 2 comprimidos de 6/6 horas se dor, por 5 dias.
Naproxeno 550mg — 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas se dor (até 5 dias).
OU Cetoprofeno 100mg — 1 caixa
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas se dor (até 5 dias).
Ondansetrona 4mg — 1 caixa
Tomar 1 comprimido de 8/8h se náusea/vômito.
Sumatriptano 50mg — 1 caixa
Tomar 1 comprimido ao iniciar sintomas de enxaqueca para abortar a crise (pode repetir se necessário).

Cefaleia pós-raqui · CID 074.5

■ PS / Sala — Refratário (na unidade)

Ringer lactato 2500ml EV em 24h.

■ Casa — Prescrição — Casa

Dipirona + mucato de isometepteno + cafeína 300/30/30mg

Tomar 2 comprimidos de 6/6 horas por 3 dias.

OU Paracetamol + cafeína 500/65mg

Tomar 2 comprimidos de 6/6h por 3 dias.

Refratário: Amitriptilina 25mg – 1 comprimido à noite por 3 noites.

Cefaleia tensional · CID R51

■ Casa — Prescrição — Casa

Paracetamol 750mg

Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor.

E/OU

Diclofenaco 50mg

Tomar 1 comprimido de 6/6 horas.

■ Profilaxia: Amitriptilina 10mg 1 a 5 cp à noite.

Crise convulsiva · CID R56

■ PS / Sala — Prescrição — PS

MOV. Se HGT <60: glicose hipertônica 50%.

Diazepam 10mg EV – repetir no máximo 2x. Se sem acesso: Midazolam 15mg IM.

Não melhorou: Fenitoína 1 amp + 250ml de SF 0,9% EV em BIC – correr em 30 minutos.

■ Procurar focos: TC crânio, eletrólitos, hemograma, PCR, Urina I. Avaliação Neurologia. Considerar IOT se não houver melhora.

Encefalopatia hipertensiva · CID I67.4

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Dieta zero. Ringer lactato 20ml/kg EV em 24 horas se necessário.

Abaixar 15% da PA na 1ª hora: Nitroprussiato de sódio 1 amp (50mg/2ml) + 250ml SG5% – iniciar infusão 5–10ml/h.

Dipirona 1g EV de 6/6 horas se dor.

Bromoprida 10mg EV de 8/8 horas se náusea/vômito.

Omeprazol 40mg EV 1x pela manhã.

■ Excluir IAM, AVC, dissecação de aorta, trauma. ECG, Rx tórax, Urina I, creatinina, eletrólitos, marcadores cardíacos (s/n), TC crânio (s/n).

Enxaqueca · CID G43

■ PS / Sala — Na unidade

Crise leve: Dipirona 1 amp EV OU Profenid 1 amp EV.

Crise moderada: Clorpromazina 1 amp EV e/ou Dramin 1 amp EV ou Bromoprida 1 amp EV.

Estado migranoso: Dexametasona 1 amp EV lento. Evitar opioides.

■ Casa — Crise (uso oral)

Sumatriptano 50mg

Tomar 1 a 2 comprimidos, dose única, se crise de enxaqueca.

OU Naproxeno 500mg

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 3 dias.

OU Ibuprofeno 400mg

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 3 dias.

■ Evitar opioides. Profilaxia: Propranolol 40mg 2 cp 1x/dia OU Metoprolol 25mg 4 cp 1x/dia OU Amitriptilina 25mg 1 cp 1x/dia OU Ácido valproico 250mg 1 cp 3x/dia.

Meningite bacteriana · CID G00.9

■ Internação — Prescrição — Internação

Ringer lactato ou SF 0,9% 20ml/kg EV.

Ceftriaxona 2g EV 12/12 horas por 7–14 dias

OU Meropenem 2g EV de 8/8 horas por 10–14 dias (suspeita pseudomonas/enterobactéria).

Se >50 anos: + Ampicilina 2g EV de 4/4 horas.

Dexametasona 0,15ml/kg EV de 6/6 horas por 2 dias (começar 30 min antes do ATB).

Dipirona (500mg/ml) 1g EV 6/6 horas.

Metoclopramida (10mg/2ml) 1 amp + AD EV 8/8 horas OU Bromoprida (10mg/2ml) 1 amp EV 8/8h.

Omeprazol (40mg/10ml) 20–40mg EV/VO 1x ao dia pela manhã.

■ Hemograma, ureia, creatinina, coagulograma, hemocultura, lactato, glicose, líquido, TC (s/n). Profilaxia de contactantes (meningococo): Ciprofloxacino 500mg VO dose única OU Rifampicina 600mg 12/12h por 2 dias.

Neuralgia do trigêmeo · CID G50.9

■ Casa — Prescrição — Casa

Carbamazepina 200mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas.
E/OU
Gabapentina 300mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas.

■ Encaminhar neurologista.

Neuralgia pós-herpética · CID G53.0

■ Casa — Tópico

Capsaicina creme 0,075%
Aplicar na região 2-3x ao dia.

■ Casa — Oral

Gabapentina 300mg
Tomar 1 a 6 comprimidos 1x ao dia.
OU Amitriptilina 25mg
Tomar 1 a 3 comprimidos 1x ao dia.

■ Após aplicar o creme pode 'queimar' por alguns minutos.

Paralisia de Bell · CID G51.0

■ Casa — Oral

Prednisona 20mg
Tomar 3 a 4 comprimidos 1x ao dia por 5-7 dias.
OU Prednisolona 20mg
Tomar 3 comprimidos 1x ao dia por 5 dias.

■ Casa — Oftálmico

Carmelose sódica
Pingar 1 gota no olho afetado sempre que necessário.

■ Hemograma, PCR (excluir infecções). Encaminhar neurologista.

Síndrome de Ramsay Hunt · CID B02.2

■ Casa — Oral

Valaciclovir 1g
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 7-10 dias.
OU Aciclovir 400mg
Tomar 1 comprimido de 4/4 horas por 10 dias.
Dipirona 1g
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor ou febre.

■ Casa — Oftálmico

Carmelose sódica
Pingar 1 gota no olho afetado sempre que necessário.

■ Casos graves (vertigem, zumbido, perda auditiva) → internar. Encaminhar neurologista.

Vertigem / Labirintite / Tontura · CID R42

■ PS / Sala — Agora (na unidade)

SF 0,9% 100ml + Dramin 1 amp EV.
Sem melhora: Metoclopramida 10mg EV.
Sem melhora: Diazepam 1 amp EV.

■ Casa — Sintomático

Dramin B6
Tomar 1 comprimido de 6/6h se náuseas ou vômitos.
Labirin 8mg – 1 caixa
Tomar 1 comprimido de 8/8h.
OU Meclín 50mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 5 dias.
Cinarizina 25mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por até 5 dias.

■ Casa — Neurite vestibular

Prednisona 20mg – 1 caixa
Tomar 3 comprimidos pela manhã por 5 dias (corticoterapia com desmame: 60mg/dia 5 dias, reduzir 10mg/dia até 10mg/dia)
Crônica: Flunarizina 10mg – 1 comprimido à noite por 5 dias.

■ Excluir AVC: score HINTS.

■ Olhos

Calázio · CID H00.1

■ Casa — Uso oftalmológico

Tobramicina 0,3% pomada
Aplicar 1 cm da pomada 2x ao dia por 5 dias.
Compressas mornas por 10 minutos 4x ao dia com massagem suave sobre a lesão.

Celulite periorbitária / pré-septal · CID H05

■ Casa — Prescrição — Casa

Amoxicilina + clavulanato 500mg – 30 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 10 dias.
OU Moxifloxacino 400mg – 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido 1x ao dia por 10 dias.

■ Compressas quentes na área inflamada 3x ao dia. Excluir celulite septal (TC).

Conjuntivite · CID H10

Exame físico

Olho [D/E] com hiperemia conjuntival discreta, sem secreção purulenta evidente. Sem edema periorbitário imp

■ Casa — Uso oftalmológico

Tobramicina 0,3% solução oftálmica – 1 frasco
Aplicar 1 gota no olho acometido, de 6/6 horas, por 7 dias.
Colírio lubrificante (Systane, Lacrifilm ou Lacrima)
Pingar 1 gota no olho afetado de 4/4 horas.
Soro fisiológico 0,9%
Aplicar compressa gelada com soro fisiológico 4x ao dia no olho afetado.

■ Casa — Uso oral

Loratadina 10mg – 7 comprimidos
Tomar 1 comprimido à noite por até 7 noites.
Dipirona 500mg
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor.

Herpes zoster oftálmico · CID B02.3

■ Casa — Prescrição — Casa

Aciclovir 400mg
Tomar 2 comprimidos de 4/4 horas por 7 dias.
Prednisona 20mg
Tomar 2 comprimidos 1x ao dia.

■ Compressas geladas; deixar a pele seca.

Neurite óptica · CID H46

■ Internação — Na internação

Dieta oral branda.
Metilprednisolona 1g + SF 400ml EV – infundir em 30-60 minutos, por 3-5 dias.
Dipirona 1-2g EV de 6/6 horas.
Metoclopramida 10mg EV + AD, de 8/8 horas, se náusea ou vômito.
Omeprazol 20-40mg VO/EV de 24/24 horas, pela manhã.

■ Solicitar hemograma, ureia, creatinina, Na, K e TC de crânio sem contraste. Avaliação oftalmo e neurologista.

Queimadura ocular (abrasão / química) · CID T26

■ Lavar olho com SF 0,9% 1 litro. Colírio anestésico. Avaliação oftalmo.

■ Otorrino

Amigdalite aguda · CID J03

■ Casa — ATB (se bacteriana)

Amoxicilina 500mg – 30 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias. (Completar os 10 dias mesmo com melhora. Buscar PS se reação)

OU Amoxicilina + clavulanato 875+125mg – 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias.

OU Clindamicina 300mg

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias.

■ Casa — Sintomáticos

Dipirona 500mg – 20 comprimidos

Tomar via oral 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.

Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml

Tomar via oral 5 mL, 2x por dia, por 5 dias.

Prednisona 20mg

Tomar 1 comprimido pela manhã, por 5 dias.

Strepsils pastilhas – 1 caixa

Dissolver 1 pastilha na boca, 2 ou mais vezes ao dia, até alívio. Máximo 10/dia.

■ Casa — Uso nasal

Lavagem nasal com soro fisiológico 0,9% – 1 frasco

Aplicar 1 seringa de 20ml em cada narina, 3x ao dia, até melhora.

Budesonida 64mcg spray nasal – 1 frasco

Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

■ Viral na maioria → sintomático. Bacteriana (Centor/estrepto) → ATB abaixo.

Cerume · CID H61.2

■ Casa — Prescrição — Casa

Cerumin

Aplicar 5 gotas no ouvido afetado 3x ao dia por 5 dias.

Dipirona 500mg

Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas se dor.

Faringoamigdalite · CID J03

■ PS / Sala — Na unidade (IM, se necessário)

Agora: Profenid OU Decadron IM.

Penicilina benzatina 1.200.000 UI – aplicar IM, dose única.

■ Casa — ATB (se necessário)

Amoxicilina 500mg – 30 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias.

OU Amoxicilina + clavulanato 875+125mg – 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias.

■ Casa — Sintomáticos

Dipirona 500mg – 20 comprimidos

Tomar via oral 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.

Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml

Tomar via oral 5 mL, 2x por dia, por 5 dias.

Prednisona 20mg

Tomar 1 comprimido pela manhã, por 5 dias.

Strepsils pastilhas – 1 caixa

Dissolver 1 pastilha na boca, 2 ou mais vezes ao dia, até alívio. Máximo 10/dia.

■ Casa — Uso nasal

Lavagem nasal com soro fisiológico 0,9% – 1 frasco

Aplicar 1 seringa de 20ml em cada narina, 3x ao dia, até melhora.

Budesonida 64mcg spray nasal – 1 frasco

Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

■ 75% viral (dor de garganta, mialgia, febre baixa, tosse, coriza, sem adenopatia). 20–40% bacteriana (hiperemia, tonsilas aumentadas, exsudato purulento, adenomegalia jugulodigástrica, leucocitose com desvio). ATB só se necessário. Na unidade: Profenid ou Decadron IM.

IVAS / Resfriado / Gripe • CID J06.9

Anamnese

PACIENTE REFERE [sintomas gripais] há [X] dias. Nega febre, nega dispneia, nega dor torácica, nega disfagia

■ Casa — Sintomáticos

Dipirona 500mg – 20 comprimidos

Tomar via oral 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.

OU Paracetamol 500mg – 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se dor ou febre.

Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml

Tomar via oral 5 mL, 3x por dia, por 5 dias.

Cetoprofeno 100mg – 1 caixa

Tomar via oral 1 comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias.

OU Diclofenaco 50mg – 10 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 5 dias.

OU Prednisona 20mg

Tomar 1 comprimido pela manhã, por 5 dias.

Strepsils pastilhas – 1 caixa

Dissolver 1 pastilha na boca, 2 ou mais vezes ao dia, até alívio. Máximo 10 pastilhas/dia.

Dropropizina 3mg/mL xarope 120 mL

Tomar 10 mL de 6 em 6 horas, por 3 dias.

OU Acetilcisteína xarope 40 mg/mL

Tomar 15 mL antes de dormir, via oral, por 5 dias.

■ Casa — Uso nasal

Lavagem nasal com soro fisiológico 0,9% – 1 frasco

Aplicar 1 seringa de 20mL em cada narina, 3x ao dia, até melhora.

Budesonida 64mcg spray nasal – 1 frasco

Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

■ Casa — ATB (se indicado)

Amoxicilina 500mg – 30 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias.

OU Amoxicilina + clavulanato 875+125mg – 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias.

OU Azitromicina 500mg – 5 comprimidos

Tomar 1 comprimido 1x ao dia por 5 dias.

OU Claritromicina 500mg – 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias.

OU Levofloxacino 750mg – 10 comprimidos

Tomar 1 comprimido 1x ao dia por 10 dias.

OU Clindamicina 300mg – 30 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias.

OU Penicilina benzatina 1.200.000 UI – IM, dose única.

Hexomedine spray – 1 frasco

Aplicar 3 jatos de 4 em 4 horas na garganta se dor.

■ Aumentar ingestão hídrica para melhorar expectoração. Anti-histamínico alternativo: Dexclorfeniramina 2mg 1 cp de 8/8h por 5 dias, ou Bilastina 20mg 1 cp VO pela manhã por 10 dias. ATB apenas se critério (Centor alto / bacteriana).

Otalgia • CID H92.0

■ Casa — Prescrição — Casa

Dipirona 500mg

Tomar 1 a 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.

Oto-Xilodase

Aplicar 5 gotas no ouvido afetado, 3x ao dia por 7 dias.

Otite externa aguda • CID H60

■ Casa — Tópico + analgesia

Ciprofloxacino + hidrocortisona (Otocirix) – 1 frasco

Aplicar 3 gotas no ouvido acometido de 12 em 12 horas por 7 dias.

Ibuprofeno 600mg

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 5 dias.

■ Casa — Otite externa fúngica

Clotrimazol 1% – 1 frasco

Aplicar 3-4 gotas no ouvido acometido de 8 em 8 horas até resolução.

■ Otite necrotizante (ambulatorial): Ciprofloxacino 500mg 1 cp 12/12h por 4 semanas. Na unidade: Dipirona + Decadron IM.

Otite média aguda · CID H66 · H65

■ Casa — ATB

Amoxicilina 500mg – 21 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias.
OU Amoxicilina + clavulanato 875+125mg – 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias.
OU Axetilcefuroxima 500mg – 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias.
OU Azitromicina 500mg – VO dose única, seguida de 250mg de 24/24h do 2º ao 5º dia.

■ Casa — OMC simples agudizada

Ciprofloxacino + hidrocortisona (Otocirix) – 1 frasco
Aplicar 3 gotas no ouvido acometido de 12 em 12 horas por 7 dias.
Ciprofloxacino 500mg – 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias.
Prednisona 20mg – 10 comprimidos
Tomar 2 comprimidos pela manhã por até 5 dias.
Proteção auricular + encaminhar ORL.

■ ATB se <6m, otorreia, OMA bilateral <24m, toxemia, otalgia >48h, T>39°C ou incerteza de reavaliação. Amoxicilina: <2a → 10 dias; >2a → 7 dias.
Na unidade: Dipirona + Decadron IM.

Perfuração de membrana timpânica · CID H72

■ Casa — Prescrição — Casa

Levofloxacino 500mg
Tomar 1 comprimido 1x ao dia por 10 dias.
Prednisona 20mg
Tomar 1 comprimido 1x ao dia por 5 dias.

■ NÃO molhar o ouvido. Retorno com otorrino em 10 dias.

Rinite alérgica · CID J30

■ Casa — Anti-histamínico

Dexclorfeniramina 2mg
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias.
OU Loratadina 10mg
Tomar 1 comprimido 1x à noite por 7 dias.
OU Hidroxizina 25mg
Tomar 1 comprimido 1x à noite por 7 dias.

■ Casa — Uso nasal

Lavagem nasal com soro fisiológico 0,9% – 1 frasco
Aplicar 1 seringa de 20ml em cada narina, 3x ao dia, até melhora.
Budesonida 64mcg spray nasal – 1 frasco
Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

Sinusite aguda · CID J01

■ Casa — Sintomáticos + nasal

Prednisona 20mg
Tomar 1 comprimido pela manhã por 5 dias.
Dipirona 500mg
Tomar 1 a 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.
Lavagem nasal com soro fisiológico 0,9% – 1 frasco
Aplicar 1 seringa de 20ml em cada narina, 3x ao dia, até melhora.
Budesonida 64mcg spray nasal – 1 frasco
Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

■ Casa — ATB (se >10 dias / dupla piora)

Amoxicilina + clavulanato 500+125mg – 30 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias.
OU Levofloxacino 750mg
Tomar 1 comprimido 1x ao dia por 5-7 dias.

■ ATB se >10 dias, sinal de dupla piora, ou febre muito alta persistente + dor facial intensa.

Tosse subaguda pós-viral · CID R05.2

■ Casa — Prescrição — Casa

Dropropizina 3mg/ml xarope 120 ml
Tomar 10 ml de 6 em 6 horas, por 3 dias.
Budesonida 50mcg nasal
Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 5 dias.

■ Tórax / Cardio-Pneumo

Asma — manutenção (GINA 2026) · CID J45

■ Casa — Track 1 (preferido) — CI-formoterol

STEP 1-2: Budesonida + formoterol 200/6 mcg – inalar 1 cápsula/dose SE NECESSÁRIO (alívio anti-inflamatório)

STEP 3 (MART): Budesonida + formoterol 200/6 mcg – 1 dose de 12/12h (manutenção) + 1 dose SE NECESSÁRIO (me

STEP 4 (MART): Budesonida + formoterol 200/6 mcg – 2 doses de 12/12h (manutenção) + 1 dose SE NECESSÁRIO (m

■ Casa — Track 2 (alternativo) — só se Track 1 indisponível

STEP 1: CI dose baixa SEMPRE que usar o SABA.

STEP 2: CI dose baixa DIÁRIO (ex.: Budesonida 200mcg 1 dose 12/12h) + Salbutamol 100mcg 1-2 jatos SE NECESS

STEP 3: CI-LABA (formoterol/budesonida ou salmeterol/fluticasona) 12/12h + SABA SOS.

STEP 4: CI-LABA dose MÉDIA 12/12h + SABA SOS.

Add-on (qualquer step, se controle insuficiente): Montelukaste 10mg à noite.

■ CONCEITO-CHAVE: NÃO usar SABA (salbutamol) isolado como alívio. Todo paciente deve ter corticoide inalatório (CI). SABA sozinho = mais crises. Enxaguar a boca após CI (evita candidíase). STEP 5: encaminhar especialista (fenotipagem, LAMA, biológicos).

Bradicardia instável · CID R00.1

■ PS / Sala — Prescrição — PS

MOV, dextro.

Atropina 1mg EV bolus – repetir a cada 3-5 minutos (máx 3mg).

Sem resposta: Dopamina 5 amp + 200ml SG – iniciar 20ml/h

OU Epinefrina (1mg) 10 amp + 90ml SG – iniciar 6ml/h (se responder, reduzir para 3ml/h).

Sem resposta: Fentanil (50mcg/ml) 2ml + 8ml SF – fazer 20 a 30 mcg OU Morfina 4 a 5 mg.

Marca-passo transcutâneo: ligar função MP, modo fixo, FC 60, iniciar estimulação (energia 40, aumentar 10 e

Transferir paciente.

Bronquite · CID J20

■ Casa — Prescrição — Casa

Beclometasona 200mcg

2 jatos de 12/12 horas por 7 dias ou até alívio dos sintomas.

Salbutamol 100mcg

2 jatos até de 4/4 horas, se crise.

Dipirona 500mg

Tomar 1 comprimido de 6/6 horas, se dor ou febre.

■ Casa — Uso nasal

Lavagem nasal com soro fisiológico 0,9% – 1 frasco

Aplicar 1 seringa de 20ml em cada narina, 3x ao dia, até melhora.

Budesonida 64mcg spray nasal – 1 frasco

Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

Coqueluche · CID A37

■ Casa — Prescrição — Casa

Azitromicina 500mg – 5 comprimidos

Tomar 1 comprimido 1x ao dia por 5 dias.

Dipirona 500mg

Tomar 1 comprimido de 6/6 horas, se dor ou febre.

Bromoprida 10mg

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas, se náusea ou vômito.

Crise de asma (exacerbação) · CID J45

■ Fala entrecortada, uso de musculatura acessória, SatO₂ <92%, sonolência/confusão, tórax silencioso → grave.

■ PS / Sala — Na unidade

O₂ se Sat <94% (meta 93–95%).

Salbutamol 100mcg: 4–10 jatos com espaçador de 20/20 min por 1 hora

+ Brometo de ipratrópio 20mcg: 4–8 jatos de 20/20 min por 1 hora.

OU nebulização: Salbutamol 10–20 gotas + ipratrópio 30–40 gotas + SF 0,9% 3ml.

Corticoide sistêmico precoce (até 1h): Prednisona 40–50mg VO OU Hidrocortisona 200mg EV.

Reavaliar após 1ª hora; se não melhorar, repetir broncodilatador.

■ PS / Sala — Crise grave / sem resposta

Sulfato de magnésio 2g EV + SF 0,9% 100–250ml – correr em 20 min (dose única).

Gasometria, considerar VNI, contato com retaguarda/UTI.

■ Casa — Para casa

Prednisona 40mg/dia por 5–7 dias (criança 3–5 dias).

Formoterol + budesonida 6/200 mcg

Manutenção: inalar 1 cápsula de 12/12h (enxaguar a boca após).

Alívio: se falta de ar/sintomas, inalar 1 cápsula extra. Não ultrapassar ~12 doses/dia (manutenção + alívio).

Encaminhar para acompanhamento.

■ GINA 2026: PREFERIR salbutamol. Fenoterol passou a NÃO recomendado (risco cardiovascular/mortalidade). MgSO₄ nebulizado sem benefício (usar EV).

Dissecção aguda de aorta · CID I71

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Dieta zero. Ringer lactato 500ml EV, s/n.

Morfina (10mg/ml): 1 amp + 9ml AD – fazer 4ml.

Deixar FC <60 e PAS entre 100 e 120: Metoprolol 5mg bolus EV – repetir de 10/10 min s/n (máx 20mg).

Se não melhorar: Niprid (50mg/2ml) 1 amp + 250ml SG5% EV em BIC, começar 2ml/h (titular).

■ ECG, Rx tórax, hemograma, lactato, ureia, creatinina, TGO, TGP. Monitorização em leito de emergência. Cateter O₂ 2L/min se Sat <92% ou dispneia. Cabeceira elevada. Sinais vitais 1/1h.

Dor torácica — abordagem rápida · CID R07

■ 6 causas que matam: SCA/IAM · Dissecção de aorta (dor rasgando, assimetria de pulso/PA) · TEP (dispneia súbita, taquicardia, dor pleurítica) · Pneumotórax hipertensivo (MV abolido, desvio traqueia, turgência) · Tamponamento (hipotensão + turgência + bulhas abafadas) · Ruptura de esôfago (vômito + dor + enfisema subcutâneo).

■ Passo 1: ECG em até 10 min + MOV. Passo 2: pensar nas 6 causas antes de 'musculoesquelético'. Score HEART estratifica SCA: 0–3 baixo (alta com troponina seriada negativa), 4–6 moderado (internar/observar), ≥7 alto (invasiva precoce/transferir). Solicitar ECG seriado (1 normal não exclui), troponina seriada (0h/1h ou 0h/3h), Rx tórax, hemograma, eletrólitos, função renal, glicemia; D-dímero se suspeita TEP + Wells baixo, Angio-TC se D-dímero+. Se SCA confirmada/suspeita → protocolo IAM e internar/transferir.

DPOC exacerbado · CID J44

■ PS / Sala — Na unidade

Nebulização: Fenoterol 10 gotas + ipratrópio 30 gotas + SF 0,9% 3ml de 20/20 min por 1 hora.

Prednisona 40mg VO OU Hidrocortisona 300mg EV.

Cateter nasal 2–3L (meta 88–92%).

■ Casa — Prescrição — Casa

Amoxicilina + clavulanato 500+125mg – 30 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 10 dias.

Prednisona 20mg

Tomar 2 comprimidos 1x ao dia por 7 dias.

Inalatório de 6/6h por 5 dias: Salbutamol 10 gotas + ipratrópio 20 gotas + SF 0,9% 2ml.

OU spray: Salbutamol 100mcg 2 jatos de 6/6h + Ipratrópio 20mcg 2 jatos de 6/6h.

Edema agudo de pulmão · CID J81

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Dieta zero (até melhora de dispneia). VNI.

Furosemida 20mg/2ml: 1mg/kg.

Morfina 10mg/ml (não para todos): 3 a 5 ml EV → 1 amp + 9ml SF.

Tridil (em cardiopatia isquêmica) ou Niprid (mais usado): 1 amp + 240ml SG 5% EV BIC (paciente 70kg começar

SVD (quantificar diurese). Glicemia capilar 2/2h. Se HGT <60: glicose hipertônica 50%. Insulina regular SOS

Monitorização. Cabeceira elevada.

Elevação importante da PA (sem LOA) · CID I16.0

■ **Reclassifica p/ EMERGÊNCIA (I16.1) se LOA:** dor torácica, dispneia, déficit neurológico, alteração visual, dor dorsal/abdominal (dissecção), gestante. Checar antes de medicar: aderência aos remédios hoje? Uso de cocaína/anfetamina/AINE/descongestionante/AO? Dor/ansiedade reativa? Glicemia capilar (descartar hipo)? ECG.

Anamnese

PACIENTE REFERE CEFALEIA/TONTURA HÁ [X]. Nega déficit neurológico focal, nega dor torácica, nega dispneia,

■ **PS / Sala — Conduta — sem LOA**

Captopril 25mg – 2 comprimidos

Tomar 1 comprimido agora. Repetir em 60 min se PA ainda $\geq 180/110$ mmHg.

OU Clonidina 0,1mg – 2 comprimidos

Tomar 1 comprimido agora. Repetir em 60 min se necessário. (Preferir em ansiedade/hiperatividade simpática,

Dipirona 1g (500mg/comp) – 4 comprimidos

Tomar 2 comprimidos VO agora se cefaleia ou dor.

OU Dipirona 500mg/ml solução oral – 40 gotas VO agora se cefaleia ou dor.

■ **Casa — Ajuste do esquema crônico**

IECA: Enalapril 10mg – 1 cp de 12/12h (ou Enalapril 20mg 12/12h) OU Captopril 25mg – 1 cp de 8/8h.

BRA: Losartana 50mg – 1 cp 1x/dia (ou 100mg 1x/dia).

BCC: Anlodipino 5mg – 1 cp 1x/dia (ou 10mg 1x/dia).

Diurético: Hidroclorotiazida 25mg – 1 cp pela manhã (ou Clortalidona 25mg pela manhã).

Retorno ao ambulatório/UBS em até 7 dias. Aumentar ingestão hídrica. Dieta hipossódica.

Retornar IMEDIATAMENTE se déficit neurológico, dor no peito, falta de ar, alteração visual, piora da cefaleia.

■ **Meta:** redução GRADUAL em 24–48h. NÃO forçar queda rápida. NÃO usar nifedipino sublingual (queda abrupta = isquemia). Emergência (I16.1) → UTI + anti-hipertensivo EV + monitorização; reduzir no máx 25% da PAM na 1ª hora (exceção dissecção). Nitroprussiato EV (EAP/encefalopatia), Nitroglicerina EV (SCA/IC), Labetalol/Nicardipino EV (AVC hemorrágico, PAS<140), Nitroprussiato+Esmolol (dissecção, PAS<120 em 20min), Hidralazina EV+MgSO₄ (eclâmpsia), Fentolamina EV (feocromocitoma). CID: I10 essencial · I16.0 sem LOA · I16.1 emergência · I16.9 não especificada.

IAM — infarto agudo do miocárdio · CID I21.9

■ **PS / Sala — Prescrição — PS**

AAS 300mg VO mastigado.

Clopidogrel 75mg: 4 comprimidos VO (ou 1 comprimido se ≥ 75 anos).

Dipirona (500mg/ml): 1g EV 6/6h.

Dinitrato de isossorbida 5mg: 1 comprimido sublingual – repetir a cada 5 min se necessário (checar contraindicações).

Morfina (10mg/ml): 1 amp + 9ml AD – fazer 2 a 5 mL, repetir a cada 5 min se necessário.

■ ECG, troponina, CK-MB. Jejum. MOV + cateter nasal se Sat <90%. SF 0,5ml/kg/h. Encaminhar/internar UTI.

Influenza / Gripe · CID J11

■ **Casa — Antiviral**

Oseltamivir 75mg

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 5 dias.

■ **Casa — Sintomáticos**

Dipirona 500mg – 20 comprimidos

Tomar via oral 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.

Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml

Tomar via oral 5 mL, 3x por dia, por 5 dias.

Cetoprofeno 100mg – 1 caixa

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias.

OU Prednisona 20mg

Tomar 1 comprimido pela manhã, por 5 dias.

Strepsils pastilhas – 1 caixa

Dissolver 1 pastilha na boca, 2 ou mais vezes ao dia, até alívio. Máximo 10/dia.

Acetilcisteína xarope 40 mg/mL

Tomar 15 mL antes de dormir, via oral, por 5 dias.

■ **Casa — Uso nasal**

Lavagem nasal com soro fisiológico 0,9% – 1 frasco

Aplicar 1 seringa de 20ml em cada narina, 3x ao dia, até melhora.

Budesonida 64mcg spray nasal – 1 frasco

Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

■ Oseltamivir: corrigir para função renal.

Insuficiência cardíaca (perfis) · CID I50

■ PS / Sala — Perfil B

Dieta zero até compensação. Restrição hídrica. VNI. Se Sat <90%: máscara O2.

Furosemida (20mg/2ml): 1mg/kg EV.

Hidralazina 25 a 100mg VO 8/8h OU Nitroprussiato (50mg/2ml): 1 amp + 248ml SG 5% EV em BIC, iniciar 10ml/h.

■ PS / Sala — Perfil C

Dieta zero. Restrição hídrica.

Furosemida (20mg/2ml): 1mg/kg EV.

Nitroprussiato (50mg/2ml): 1 amp + 248ml SG 5% EV, iniciar 10ml/h.

Se hipotensão: Noradrenalina (1mg/ml) 20ml + 80ml SG5% EV em BIC, iniciar 1ml/h. Encaminhar.

■ PS / Sala — Perfil D

Dieta oral conforme aceitação.

SF 0,9% 20ml/kg em 24h. Encaminhar.

Oclusão arterial aguda · CID I74.3

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Enoxaparina 1mg/kg 12/12h.

Aquecimento passivo do membro.

Contato com cirurgião vascular.

■ Hemograma, ureia, creatinina, Na, K, coagulograma / USG doppler arterial urgente. Não aguardar exames para iniciar tratamento.

Pneumonia · CID J18

■ Casa — Ambulatorial

Amoxicilina + clavulanato 875/125mg – 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 10 dias.

OU Levofloxacino 500mg – 7 comprimidos

Tomar 1 comprimido 1x ao dia por 7 dias.

Dipirona 500mg

Tomar 1 comprimido de 6/6 horas, se dor ou febre.

Bromoprida 10mg

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas, se náusea ou vômito.

■ Internação — Internação / paciente grave (PSI/PORT)

Solicitar: Rx tórax; hemograma, ureia, creatinina, eletrólitos. Avaliar necessidade de internação.

Levofloxacino 750mg: 1 amp 1x/dia

OU Ceftriaxona 2g 1x/dia + Azitromicina 500mg 1x/dia EV

OU Clavulin + Azitromicina 500mg 1x/dia EV

Glicemia capilar 4/4h. Se HGT <60: glicose hipertônica 50%. Insulina regular SOS.

■ Solicitar Rx e laboratório. Internação se SatO2 <92%. CURB-65: 0–1 ambulatorial; ≥2 considerar internação; ≥3 grave. Nebulização com SF 0,9%.

Taquiarritmias · CID I49

■ PS / Sala — Paciente instável — cardioversão

Flutter atrial: cardioversão sincronizada 50J.

Fibrilação atrial: cardioversão sincronizada 120J.

Taquicardia supraventricular: cardioversão sincronizada 50J.

TV monomórfica: cardioversão sincronizada 100J.

TV polimórfica: cardioversão sincronizada 200J.

Torsades de pointes: desfibrilação 200J bifásico + sulfato de Mg 2g EV em 15 min.

Cardioversão: monitorizar, acesso venoso; Fentanil (100mcg/2ml) 1 amp + 8ml AD – 2ml EV bolus; Etomidato (2

■ PS / Sala — Paciente estável

MOV, dextro.

Taquicardia supraventricular: manobra vagal e/ou Adenosina 6mg/12mg EV bolus + flush 10ml SF.

Fibrilação atrial: Amiodarona 300mg + 250ml SG5% em 30 min. Manutenção: Amiodarona 900mg em 250ml SG5% em 2

OU Metoprolol 5mg EV em 5 min (1mg/min) – repetir a cada 15 min se necessário (máx 15mg).

OU Diltiazem 0,25mg/kg EV em infusão lenta.

Flutter atrial: Amiodarona 300mg + 150ml SG5% em 30 min. Manutenção igual.

OU Metoprolol 5mg EV.

TV monomórfica/polimórfica: Amiodarona 150mg EV em 10 min. Manutenção: 1mg/min (6h), 0,5mg/min (18h).

Torsades de pointes: sulfato de Mg 2g EV em 15 min.

Tosse / SRAG

■ Casa — Prescrição — Casa

Vick 44E – 1 frasco
Tomar 15 ml de 8 em 8 horas se tosse persistente.
OU Dropropizina 3mg/ml xarope 120 ml
Tomar 10 ml de 6 em 6 horas, por 3 dias.
Strepsils pastilhas – 1 caixa
Dissolver 1 pastilha na boca, 2 ou mais vezes ao dia, até alívio. Máximo 10/dia.
Oseltamivir 75mg – 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias.
Loratadina 10mg – 7 comprimidos
Tomar 1 comprimido à noite por 7 dias.

Tromboflebite superficial · CID I80

■ Casa — Baixo / intermediário risco

Ibuprofeno 400mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas.
OU Diclofenaco 50mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas.
Risco intermediário, por 45 dias: Enoxaparina 40mg/0,4ml SC 24/24h por 45 dias OU Rivaroxabana 10mg 1x ao dia

■ Casa — Alto risco (fatores TEV/TVP)

Ibuprofeno 400mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas.
OU Diclofenaco 50mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas.
Por 3 meses: Enoxaparina 1mg/kg SC 12/12h OU Rivaroxabana 15mg 12/12h por 21 dias, após Rivaroxabana 20mg 1

■ Avaliar risco (Whitebook). Orientações: compressa morna ou fria 3x/dia até melhora, elevação dos membros, meias compressivas.

Trombose venosa profunda · CID I82

■ Casa — Ambulatorial

Rivaroxabana 15mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 3 semanas.
Depois: Rivaroxabana 20mg – 1 comprimido 1x ao dia por 3 meses.
Dipirona 1g
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor.
Deocil SL 10mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas se dor intensa.
OU Varfarina 5mg – 1 comprimido às 18h. Controle INR a cada 15 dias.

■ Internação — Internação

Dieta sem restrições.
Enoxaparina 1mg/kg (máx 100mg) SC 12/12 horas.
OU se clearance <30: Heparina não fracionada 25000 UI/5ml – fazer 5ml + SF 0,9% 245ml (100U/ml); ataque 80U
E Varfarina 5mg VO 1x ao dia. Controle TAP/INR.
Dipirona 1g 6/6h. Bromoprida 10mg EV 8/8h. Cetoprofeno 1 amp EV 12/12h.

■ Hemograma, ureia, creatinina, Na, K, TGO, TGP, USG doppler venoso. Manter membros elevados, repouso relativo. Alta hospitalar quando INR entre 2 e 3.

■ Abdome / Gastro

Abdome agudo obstrutivo · CID K56.6

■ PS / Sala — Brida / aderência

Dieta zero. Sonda nasogástrica aberta.
Dipirona 2g EV 4/4h.
Tramal 100mg + Bromoprida 10mg EV, se necessário.
Luftal 125mg 4/4h VO ou SNG.
500ml SF 0,9% + 5 amp SG 50% + 1 amp NaCl 20% + 1 amp KCl 19,1% 6/6h.
Sinais vitais.

■ Rx abdome agudo (tórax AP, abdome deitado e em pé), hemograma, PCR, ureia, creatinina, Na, K. Aguardar 24–36h ou chamar cirurgia. Se repercussão sistêmica (febre, taquicardia, leucocitose, prostração): chamar cirurgia.

Afta · CID K12.0

■ Casa — Uso local

Omcilon-A (triancinolona)
Aplicar pequena quantidade sobre a lesão 3x ao dia por 7 dias.

Apendicite aguda (Alvarado) · CID K35

■ Dor que MIGRA para FID, anorexia, náusea/vômito, febre. Mulher jovem com dor em FID → sempre pensar em causa ginecológica (ectópica, cisto roto, DIP) e pedir beta-hCG.

■ PS / Sala — Conduta na unidade

Dieta zero. SF 0,9% ou Ringer lactato EV.

Dipirona 1g EV 6/6h se dor.

Ondansetrona 4mg EV 8/8h se náusea/vômito.

Se cirurgia indicada / suspeita perfuração → ATB pré-op: Ceftriaxona 2g EV 1x ao dia + Metronidazol 500mg Avaliação/contato cirurgia geral.

■ Score de Alvarado (MANTRELS, 0–10): Migração 1 · Anorexia 1 · Náusea/vômito 1 · Dor à palpação FID 2 · Descompressão dolorosa 1 · Temperatura $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ 1 · Leucocitose >10.000 2 · Desvio à esquerda 1. ≤ 4 improvável (alta com retorno); 5–6 observação+imagem; 7–8 imagem+cirurgia; ≥ 9 cirurgia direta. Solicitar hemograma, PCR, Urina I, beta-hCG (toda mulher fértil), USG (jovens magros/crianças/gestantes) ou TC com contraste. Analgesia NÃO mascara o diagnóstico — pode/deve dar.

Candidíase oral · CID B37

■ Casa — Uso tópico

Nistatina 100.000 UI/ml

Tomar 1 a 6 ml 4x ao dia por 7–14 dias. Bochechar e manter por vários minutos na cavidade oral antes de engolir.

Colecistite aguda · CID K81

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Dieta zero. Ringer lactato 500ml EV.

Dipirona 1g EV 6/6h.

Cetoprofeno 100mg EV 12/12h.

Bromoprida 10mg EV 8/8h.

Ceftriaxona 2g EV 24/24h.

Metronidazol 500mg EV 8/8h.

■ Hemograma, PCR, Na, K, ureia, creatinina, TGO, TGP, bilirrubina total e frações, FA, gama GT, amilase, lipase, USG abdome superior. Sinais vitais 6/6h.

Colite pseudomembranosa · CID A04.7

■ Casa — Prescrição — Casa

Metronidazol 250mg

Tomar 2 comprimidos de 8/8 horas por 10 dias.

OU Vancomicina 125mg

Tomar 1 comprimido de 6/6 horas por 10 dias.

■ Hemograma, ureia, creatinina, Na, K, albumina.

Constipação · CID K59.0

■ Casa — 1ª linha

Plantago ovata Forssk — 1 caixa

Diluir 1 envelope em 1 copo de água, 1x ao dia até melhora (pode repetir de 8/8h).

OU Policarbofila cálcica 625mg

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas, junto com as refeições.

OU Óleo mineral

Tomar 1 colher de sopa (20 ml) de 12/12 horas.

OU Lactulose 667 mg/mL — 1 frasco

Tomar 15 ml 1x ao dia até melhora (máx 60 ml/dia).

■ Casa — Se não melhorar

Poli(etil)enoglicol 4000

Tomar 10g diluídos em água ou suco 1x ao dia.

OU Hidróxido de magnésio 1200mg/15ml

Tomar 30 ml 1x ao dia.

OU Bisacodil 5mg — 1 caixa

Tomar 1 comprimido 1x ao dia (ou 12/12h se resistência a outras medidas).

■ Se intensa: clister glicerinado 500ml agora.

Cólica biliar · CID K80

■ Casa — Prescrição — Casa

Dipirona 500mg – 40 comprimidos
Tomar 2 comprimidos de 6/6 horas se dor ou febre por 5 dias.
OU Paracetamol 750mg – 40 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor ou febre por 5 dias.
Buscopan composto – 1 caixa
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor ou cólica.
Diclofenaco 50mg – 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas se dor intensa por até 5 dias.
Tramadol 50mg – 12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas se dor muito intensa e resistente.
Ondansetrona 8mg sublingual – 1 caixa
Deixar 1 comprimido abaixo da língua até absorção, de 8/8 horas se náusea ou vômito.
OU Metoclopramida 10mg – 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas se náusea ou vômito.

Disenteria · CID A09

■ Casa — Prescrição — Casa

Ciprofloxacino 500mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 3-5 dias.
OU Azitromicina 1g
Tomar 1 comprimido, dose única.
OU Azitromicina 500mg
Tomar 1 comprimido 1x ao dia por 3-5 dias.
Albendazol 400mg
Tomar 1 comprimido 1x ao dia por 3 dias (associar se indicado).

Diverticulite aguda · CID K57

■ PS / Sala — Complicada

Dieta zero. Ringer lactato 500ml EV.
Ceftriaxona 2g EV 24/24h.
Metronidazol 500mg EV 8/8h.
Dipirona 1g EV 6/6h SN. Bromoprida 10mg EV 8/8h SN. Sinais vitais 6/6h.

■ Casa — Não complicada

Ciprofloxacino 500mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 7 dias.
Metronidazol 250mg
Tomar 2 comprimidos de 8/8 horas por 7 dias.
Dipirona 500mg
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor.

■ Hemograma, PCR, Na, K, ureia, creatinina, TC abdome com contraste. Dieta sem resíduos (leve, sem sementes).

DRGE / Gastrite · CID K21 · K29

■ Casa — IBP

Omeprazol 20mg – 28 comprimidos
Tomar 2 comprimidos 1x ao dia, em jejum (30 min antes da refeição), por 14 dias.
OU Pantoprazol 20mg
Tomar 1 a 2 comprimidos pela manhã.
OU Dexlansoprazol (Dexilant) 30mg
Tomar 1 comprimido pela manhã, por 30 dias.

■ Casa — Procinético / antiácido

Domperidona 10mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas.
OU Bromoprida 10mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas.
Hidróxido de magnésio 60mg/ml
Tomar 5-10 ml VO 1 hora após as refeições e ao deitar.
Pepsamar (hidróxido de alumínio) 230mg – 1 caixa
Mastigar 2 comprimidos ao sentir azia intensa.

■ Manter tratamento 4-8 semanas; não comer antes de deitar; evitar refeições volumosas; cessar tabagismo; evitar café/chocolate/álcool.

Enterobíase / Oxiurose · CID B80

■ Casa — Prescrição — Casa

Albendazol 400mg
Tomar (10mg/kg – máximo 400mg) 1x ao dia por 3 dias.
Dipirona 1g
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor ou febre.
Hidroxizina 25mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas se coceira.

Epigastralgia / Pirose · CID R10.1 · K29

■ Casa — Prescrição — Casa

Hidróxido de alumínio
Tomar 15 ml 3x ao dia, 15 minutos antes das principais refeições.
OU Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + simeticona
Tomar 10 ml 4x ao dia, 1 hora antes das refeições.
Dipirona 500mg
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor.
Omeprazol 20mg
Tomar 1 comprimido 1x ao dia, pela manhã, por 10 dias.
Buscopan composto
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas se dor.
Ondansetrona 4mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas se náusea.

GECA / Gastroenterite (adulto) · CID A09

Anamnese

PACIENTE REFERE DIARREIA HÁ [X] DIA(S). Nega febre, nega sangue nas fezes, nega vômitos persistentes, nega
#Medicamentos de uso contínuo: nega #Comorbidades: nega #Alergias: nega #Gestação: [avaliar]

Exame físico

Bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Abdome discretamente distendido, plano, dor discreta à palpação difusa, sem defesa ou rigidez.

■ Casa — Prescrição — Casa

Soro de hidratação oral – 4 sachês
Diluir 1 sachê em 1L de água filtrada e tomar 1 copo a cada evacuação. Armazenar em geladeira, descartar no
Dipirona 500mg – 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor ou febre.
Buscopan composto – 1 caixa
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor ou cólica.
Metoclopramida 10mg – 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas se náusea ou vômito.
OU Ondansetrona 4mg sublingual – 1 caixa
Deixar 1 a 2 comprimidos abaixo da língua até dissolver, de 8/8 horas se náusea ou vômito.
Floratil – 1 caixa
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 3 dias.
Racecadotril 100mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas até cessar a diarreia (até 3-5 dias), associado a hidratação oral.
Simeticona gotas – 1 frasco
Tomar 50 gotas de 8/8 horas se gases.

■ Casa — Se epigastralgia

Omeprazol 20mg – 28 comprimidos
Tomar 1 comprimido 1x ao dia, em jejum, aguardar 30 min para alimentar, por 14 dias.

■ Casa — Se precisar de ATB

Ciprofloxacino 500mg – 6 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 3 dias.
OU Sulfametoxazol-trimetoprima 800/160mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 3 a 5 dias.

■ Zinco (criança): <5 anos 20mg/dia por 10 dias; <6 meses 10mg/dia por 10 dias.

Hemorragia digestiva alta · CID K92.2

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Dieta zero. Ringer lactato 500ml EV agora (20–30ml/kg de ressuscitação).

■ PS / Sala — HDA varicosa

Ceftriaxona 2g EV agora.

Terlipressina 2mg EV agora.

■ PS / Sala — HDA não varicosa

Omeprazol 40mg EV agora (manter de 12/12 horas).

■ Monitorização. Concentrado de hemácias se Hb <7. Noradrenalina 4 amp + 254ml SG5% EV em BIC — iniciar 5–10ml/h (alvo PAM <65) se necessário. SVD (meta 0,5ml/kg/h). Solicitar EDA e UTI.

Hemorroida · CID I84

■ Casa — Uso oral

Plantago ovata (Metamucil/Fibermais/Muvinlax)

Tomar 1 a 3 sachês, diluídos em 200 ml de água.

Lactulose

Tomar 15 ml de 8/8 horas.

Dipirona 500mg

Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor.

Cetoprofeno 100mg

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 3–5 dias.

■ Casa — Uso externo

Xyloproct pomada

Aplicar fina camada várias vezes ao dia na área afetada (ou usar o aplicador).

OU Hidrocortisona creme 10mg/g

Aplicar fina camada na região afetada 2 a 3 vezes por dia, por no máximo 2 semanas.

■ Banho de assento: água morna por 15 min, 2x ao dia.

Ingesta de corpo estranho · CID T18.9

■ Rx abdome (deitado e em pé) e tórax. Objeto perfurocortante/pilhas/bateria/grandes, objeto no esôfago, paciente sintomático → EDA + avaliação cirurgia. Outros: orientar sinais de alarme, retorno em 24–48h para novo Rx.

Pancreatite aguda · CID K85

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Dieta zero (até melhora clínica).

Ringer lactato 1000ml EV agora.

Ringer lactato 500ml + 7 amp (10ml) glicose hipertônica 50% + 1 amp (10ml) KCl 8/8 horas.

Dipirona 1g EV 6/6 horas.

Cetoprofeno 100mg EV 12/12h.

Morfina 2mg/ml: 2–4ml 4/4h se necessário.

Ondansetrona 4mg/ml 8/8h EV.

■ Hemograma, FA, gama GT, TGO, TGP, bilirrubinas, amilase, lipase, PCR, glicemia, Na, K, USG abdominal e/ou TC abdome. SVD (quantificar diurese, ideal >0,5ml/kg/h). Sinais vitais 6/6h.

Parasitose · CID B80

■ Casa — Prescrição — Casa

Albendazol 200mg

Tomar 2 comprimidos, dose única.

Solução · CID R06.6

■ Casa — Prescrição — Casa

Clorpromazina 25mg

Tomar 1 a 2 comprimidos de 12/12 horas por 5 a 10 dias.

OU Gabapentina 300mg

Tomar ½ comprimido de 8/8 horas por 5 a 10 dias.

OU Bromoprida 10mg

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 5 a 10 dias.

OU Baclofeno 10mg

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 5 a 10 dias.

Xerostomia · CID R68.2

■ Casa — Prescrição — Casa

Goma de mascar sem açúcar.
Pilocarpina 4% (40mg/ml)
Aplicar 3 gotas 3x ao dia, durante ou após as refeições.
Saliva artificial (Kin-Hidrat)
Usar conforme necessidade.
Dexpantenol
Aplicar nos lábios 2-3x ao dia.

■ Consumir acerola, limão, maçãs, peras; umedecer a cavidade oral com água filtrada ou gelo.

■ Renal / Endócrino / Metabólico

Cetoacidose diabética · CID E14.1

■ Internação — Reposição volêmica / eletrólitos

Dieta zero. 15-20 ml/kg SF0,9% na primeira hora.
Após exames – Na normal-alto: NaCl 0,45% 250-500ml/h; Na baixo: NaCl 0,9% 250-500ml/h.
Quando glicemia = 200: soro glicosado 5% + NaCl 0,45% 150-250ml/h.
K <3,3: KCl 10% (1g/10ml) 10ml + NaCl 0,45% 100ml – 20-40 mEq/h até K >3,3 (NÃO dar insulina).
K entre 3,3 e 5,5: KCl 10% 10ml + NaCl 0,45% 100ml – 20-30 mEq em cada litro EV.
K >5,5: dosar novamente em 2 horas.
Se pH <6,9: bicarbonato de sódio 8,4% (1mEq/ml) 100ml + SF0,9% 400ml – correr em 2 horas.

■ Internação — Insulina

Grave: Insulina regular (100UI/ml) 1ml + 99ml SF0,9% (1 UI/ml) – 0,1 UI/kg em bolus; após 0,1 UI/kg/h EV em BI.
Leve-moderado: Insulina regular 0,3 UI/kg SC dose única; após 0,2 UI/kg SC de 2/2h. Quando glicemia = 200: 1 UI/kg EV 6/6h.
Dipirona 1g EV 6/6h. Bromoprida 10mg EV 8/8h. O2 se necessário.

■ Dextro, gasometria arterial, Urina I, Na, K, hemograma, ureia, creatinina, ECG. Glicemia capilar 1/1h (estável por 3h → 2/2h). Ureia/creatinina/Na/K de 2/2h até estabilização. Internar.

Estado hiperglicêmico hiperosmolar · CID E14

■ Internação — Prescrição — Internação

Dieta zero. SF0,9% 15-20 ml/kg na primeira hora.
Após exames – Na normal-alto: NaCl 0,45% 150-250 ml/h.
Quando glicemia = 300: solução glicosada 5% 150ml + SF 150ml – infundir 150 ml/h.
K <3,3: KCl 10% (1g/10ml) 10ml + NaCl 0,45% 100ml – 20-40 mEq/h até K >3,3 (NÃO dar insulina).
K entre 3,3 e 5,5: KCl 10% 10ml + NaCl 0,45% 100ml – 20-30 mEq por litro EV.
Insulina regular (100UI/ml) 1ml + 99ml SF0,9% – 0,1 UI/kg bolus; após 0,1 UI/kg/h EV em BI. Quando glicemia = 300: 1 UI/kg EV 6/6h.
Dipirona 1g EV 6/6h. Bromoprida 10mg EV 8/8h.

■ Dextro, gasometria arterial, Urina I, Na, K, hemograma, ureia, creatinina, ECG. Glicemia capilar 1/1h. Ureia/creatinina/Na/K de 2/2h. Internar.

Hiperglicemia · CID R73.9

■ PS / Sala — Insulina regular SC conforme glicemia capilar

Glicemia 150-250: 2 UI
Glicemia 250-300: 4 UI
Glicemia 300-350: 6 UI
Glicemia 350-400: 8 UI
Glicemia >400: 10 UI

■ Cuidado com CAD e EHH!

Hiperpotassemia · CID E87.5

■ PS / Sala — Se ECG alterado

Gluconato de cálcio 10% 10ml + SG5% 100ml EV em BIC em 2-3 min.
Insulina regular 10 UI + SG10% 500ml EV em BIC em 60 minutos.
OU nebulização com salbutamol: 10 gotas + 3ml SF – repetir até 3x.
OU Furosemida (20mg/2ml): 1 amp de 12/12h.

Hipoglicemia · CID E16.2

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Glicose hipertônica 50%: 4 a 6 amp EV (começar com 4).
Sem acesso venoso (incomum): Glucagon 1mg IM.
Hepatopatas, etilistas, desnutridos: Tiamina 100mg EV.

Hiponatremia • CID E87.1

■ PS / Sala — Grave (<120) e aguda

SF 0,9% 445 ml + NaCl 20% 55ml – infundir em BI durante 12 horas.
Solicitar Na após.

Hipopotassemia • CID E87.6

■ PS / Sala — Moderado/grave (K <3)

KCl 19,1% 15 ml (1,5 ampola) + SF 0,9% 1 litro – EV em BIC 250 ml/h por 4 horas.

■ Casa — Leve

KCl xarope 6%
Tomar 15ml VO de 8/8 horas.
OU Cloreto de potássio 600mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas.

Rabdomiólise • CID M62

■ Hemograma, ureia, creatinina, fósforo, K, Ca, TGO, TGP, GGT, glicose, ácido úrico, gasometria venosa, CPK, Urina I, ECG. CPK <3000 sem disfunção renal: hidratação + CPK diário. CPK >5000 e lesão renal: internação, SF/Ringer, monitorar débito urinário, corrigir distúrbios (hipercalcemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia).

■ Hematologia

Anemia ferropriva • CID D50.9

■ Casa — Prescrição — Casa

Sulfato ferroso (200mg ferro elementar)
Tomar 1 comprimido 1x ao dia, 30 minutos antes ou 60 minutos após as refeições. De preferência com suco de

Anemia megaloblástica • CID D51

■ Casa — Vitamina B12

Cianocobalamina 2500 mcg/ml
Aplicar 5000 mcg IM a cada 7 dias por 4 semanas; após, 5000 mcg IM a cada 30 dias por 2 meses.
OU Cianocobalamina 1000mcg
Tomar 1 comprimido 1x ao dia.

■ Casa — Ácido fólico

Ácido fólico 5mg
Tomar 1 comprimido 1x ao dia.

Crise algica falcêmica • CID D57

■ PS / Sala — Prescrição — PS

SF 0,9% 500ml (3 a 5L/24h).
Leve: Dipirona 1g EV.
Moderada: Tramadol 100mg + 100ml SF 0,9% + Bromoprida EV lento.
Intensa: Morfina (2mg/2ml) 2ml, repetir em 5 min se não melhorar.

■ Síndrome torácica aguda: SF 0,9% 2 a 3L/24h; se Sat <90%: O2; Ceftriaxona 2g 1x/dia EV + Azitromicina 500mg 1x/dia VO.

Epistaxe • CID R04.0

■ Avaliar sinais de trauma → ABCD, imagem. Avaliar uso de AAS/Clopidogrel/Marevan e HAS descontrolada. Manter paciente sentado com cabeça levemente fletida. Tampão anterior: gaze + pinça Kelly + 1 amp adrenalina (ou ácido tranexâmico 50mg/ml 5–10ml) + xylocaína gel. Se não melhorar: ácido tranexâmico 1 amp + 250ml SF 0,9% correr em 10–30 min. Observação e encaminhar especialista.

Neutropenia febril · CID D72.9

■ Casa — Ambulatorial

Amoxicilina + clavulanato 875/125mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas.
Ciprofloxacino 500mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas.
OU Levofloxacino 500mg
Tomar 1 comprimido 1x ao dia.

■ Internação — Internação

Cefepime 2g 8/8 horas
OU Meropenem 1g 8/8 horas
OU Tazocin 4,5g 6/6 horas.
Se infecção cutânea: acrescentar Vancomicina 2g 8/8 horas.
Se diarreia por Clostridium: Vancomicina 500mg VO.

■ Hemograma, função renal, eletrólitos, função hepática, PCR, lactato, hemocultura. MASCC score para definir local de tratamento.

Transusão de hemoderivados

■ PS / Sala — Hemácias

Concentrado de hemácias (1 unidade aumenta 1 Hb e 3% Ht) – nos primeiros 30 min, 15 gotas/min (média 1-2 h)
Dipirona 500mg – 1g EV de 6/6 horas.
Metoclopramida 10mg/2ml – 1 amp EV.
Se histórico de reação alérgica: Difenidramina 50mg/ml – 10-50mg IM profunda ou EV em 5-30 min OU Prometazina 1mg/kg
Dosar Hb/Ht em 1-2 horas.

■ PS / Sala — Plaquetas

Concentrado de plaquetas (50-60ml/bolsa) – 1 unidade/10kg – infundir em 30 minutos.
Dipirona 500mg – 1g EV de 6/6 horas.
Metoclopramida 10mg/2ml – 1 amp EV.

■ MSK / Reumato / Orto

Dor crônica · CID R52.2

■ Casa — Prescrição — Casa

Dipirona sódica 500mg – 40 comprimidos
Tomar 2 comprimidos por via oral a cada 6 horas, em horários fixos (6h-12h-18h-00h). Máx 4 g/dia.
Naproxeno 500mg – 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas, junto com alimento, por no máximo 5 dias.
OU (idoso, HAS)
Celecoxibe 200mg – caixa com 10 cápsulas
Tomar 1 cápsula por via oral 1 vez ao dia.
Diclofenaco gel 1% – bisnaga 60g
Aplicar 2-3g sobre a articulação dolorosa, 3 a 4 vezes ao dia.
Gabapentina 300mg – caixa com 30 cápsulas
Iniciar 1 cápsula à noite por 7 dias; após, 1 cápsula de 8/8 horas conforme tolerância.
Tramadol 50mg – caixa com 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas somente nos dias de dor intensa. Não usar de forma contínua.

■ Casa — Dor articular

Sulfato de glucosamina 1500mg + sulfato de condroitina 1200mg
Tomar 1 sachê ao dia, dissolvido em água, junto com refeição.

Entorse de tornozelo · CID S93.4

■ Casa — Prescrição — Casa

Dipirona 500mg
Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6 horas se dor.
Cetoprofeno 100mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 5 dias.
OU Ibuprofeno 600mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 5 dias.
Se dor intensa: Tramadol 100mg – 1 comprimido de 8/8 horas se dor intensa.

■ Gelo local 5x/dia por 20 min; imobilização 1-2 semanas; elevação do membro; repouso relativo.

Fasciíte plantar · CID M72.2

■ Casa — Prescrição — Casa

Cetoprofeno 100mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 7 dias.
Dipirona 500mg
Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6 horas se dor.

■ Alongamento; calçados com bom amortecimento; perda ponderal; calor local 4x/dia 20 min.

Gota · CID M10

■ Casa — Crise aguda

Naproxeno
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 5 dias.
OU Ibuprofeno 600mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 5 dias.
OU Prednisona 20mg
Tomar 1 comprimido 1x ao dia por 5 dias.
OU Colchicina 0,5mg
Tomar 2 comprimidos; após 1 hora, 1 comprimido; em seguida, 1 comprimido de 12/12 horas.

■ Na unidade: Profenid 1 amp IM. Profilaxia: Alopurinol 100mg 1 cp 1x ao dia.

Insuficiência venosa crônica · CID I87.2

■ Casa — Prescrição — Casa

Diosmina + hesperidina 450+50mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas.
Se úlcera: Pentoxifilina 400mg – 1 comprimido de 12/12 horas até cicatrização.
Se dermatite de contato: Triancinolona OU Betametasona – passar na lesão 2x ao dia até melhora.

■ Elevação dos MMII 30 min 3x/dia; atividade física; meia de compressão elástica.

Lombalgia / Mialgia · CID M54.5 · M79.1

Anamnese

PACIENTE REFERE LOMBALGIA HÁ [X] DIAS. Dor pior ao movimento e melhora com repouso. Nega irradiação. Nega t

Exame físico

Bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Coluna lombar discretamente dolorosa à palpação paravertebral, sem deformidades. Mobilidade normal, dor que

■ Casa — Prescrição — Casa

Dipirona 500mg – 40 comprimidos
Tomar 2 comprimidos por via oral a cada 6 horas, se dor. (Opção: horários fixos 6h-12h-18h-00h; máx 4 g/dia)
Naproxeno 500mg – 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas, junto com alimento, por no máximo 5 dias.
OU Cetoprofeno 100mg – 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas, junto com alimento, por no máximo 5 dias.
OU Diclofenaco 50mg – 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 5 dias.
Ciclobenzaprina 5mg
Tomar 1 comprimido 30 min antes de dormir, por 5 dias (pode causar sono).

■ Casa — 2ª via (dor intensa)

Tramal Retard 100mg – 1 caixa
Tomar 1 comprimido de 6/6h se dor intensa.
Paracetamol + codeína 500+30mg – 1 caixa
Tomar 1 comprimido de 8/8h se dor intensa.

Osteoartrite • CID M19

■ Casa — Uso oral

Dipirona 500mg
Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6 horas se dor.
E/OU
Diclofenaco 25mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 5 dias.
OU Tramal 100mg
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor intensa.
OU Duloxetina 30mg
Tomar 1 comprimido por dia por 7 dias; após, 2 comprimidos por dia.

■ Casa — Uso tópico

Diclofenaco gel
Aplicar fina camada na articulação acometida 3x ao dia.
OU Nimesulida gel
Aplicar fina camada na articulação acometida 2x ao dia.

■ Perda de peso; atividade física.

■ Genitourinário / Gineco

Atrofia urogenital • CID N90

■ Casa — Uso vaginal

Estradiol 10mcg/comprimido
Aplicar 1 comprimido via vaginal 2x na semana.
OU Promestrieno creme vaginal 10mg
Aplicar à noite por 30 noites.

■ Checar contraindicações.

Bacteriúria assintomática • CID N39

■ Casa — Prescrição — Casa

Nitrofurantoina 100mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 5-7 dias.
OU Amoxicilina 500mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 5-7 dias.
OU Fosfomicina 3g
Tomar 1x, dose única.

■ Tratar apenas em situações específicas (gestante, pré-procedimento urológico).

Balanite • CID N51.2

■ Casa — Tópico

Nitrato de miconazol creme 2%
Aplicar nas lesões 2x ao dia.
Hidrocortisona 1% creme
Aplicar nas lesões 2x ao dia.

■ Casa — Oral

Fluconazol 150mg
Tomar 1 comprimido, dose única.
Dipirona 500mg
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor.
Desloratadina 5mg
Tomar 1 comprimido 1x ao dia se coceira.

Cancro mole • CID A57

■ Casa — Prescrição — Casa

Azitromicina 500mg – 2 comprimidos
Tomar 2 comprimidos VO em dose única.

Candidíase vaginal · CID B37

■ Casa — Uso vaginal

Miconazol creme 2%
1 aplicador intravaginal à noite por 7 noites.

■ Casa — Uso oral

Fluconazol 150mg
Tomar 1 comprimido, dose única.
Recorrente: Fluconazol 150mg 1 cp a cada 3 dias por 3 doses; depois 1 cp por semana por 6 meses.

■ NÃO dar fluconazol para gestante!

Cervicite · CID N72

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Ceftriaxona 250mg IM dose única.

■ Casa — Prescrição — Casa

Azitromicina 1g
Tomar 1 comprimido, dose única.

Cistite / ITU não complicada · CID N30 · N39

■ Casa — 1ª linha

Nitrofurantoína 100mg – 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas por 5 dias.
OU Fosfomicina 3g – 1 envelope
Diluir em ½ copo e tomar em dose única antes de dormir.
OU Cefalexina 500mg – 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas por 5 dias.

■ Casa — 2ª linha

Ciprofloxacino 500mg – 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 5 dias.
OU Amoxicilina + clavulanato 500/125mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 7 dias.

■ Casa — Sintomáticos

Pyridium 100-200mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 (a 12/12) horas, após as refeições, por no máximo 2 dias (urina fica laranja).
Dipirona 500mg – 40 comprimidos
Tomar 2 comprimidos de 6/6 horas se dor ou febre por 5 dias.
OU Paracetamol 750mg – 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor ou febre.

Climatério (sintomas vasomotores) · CID N95.1

■ Casa — Prescrição — Casa

Isoflavona de soja 200mg – 1 caixa
Tomar 1 comprimido VO de 24/24h por 30 dias.

Cólica menstrual / SUA · CID N94

■ Casa — Prescrição — Casa

Dipirona 500mg – 40 comprimidos
Tomar 2 comprimidos de 6/6 horas se dor ou febre por 5 dias.
OU Paracetamol 500mg – 40 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor ou febre por 5 dias.
Buscopan composto – 1 caixa
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor ou cólica.
Diclofenaco 50mg – 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 5 dias.
Ácido mefenâmico 500mg – 1 caixa
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas se cólica intensa.
OU Ácido tranexâmico 250mg – 36 comprimidos
Tomar 4 comprimidos, 3 vezes ao dia, por 3 dias.

Escroto agudo · CID N51.1

■ Hemograma, PCR, Urina I, urocultura, USG doppler bolsa escrotal. Encaminhar urologia/cirurgia.

Gonorreia (+ clamídia) · CID A54

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Ceftriaxona 500mg IM dose única agora.

■ Casa — Prescrição — Casa

Doxiciclina 100mg

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 7 dias.

OU (gestante)

Azitromicina 500mg

Tomar 2 comprimidos, dose única.

Herpes genital · CID A60

■ Casa — Prescrição — Casa

Aciclovir 200mg – 50 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 4/4h (exceto 1 dose noturna) por 10 dias. Horário sugerido: 06:00 / 10:00 / 14:00 / 18:00

OU Aciclovir 400mg

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 5–7 dias.

Dipirona 1g

Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor ou febre.

■ Profilaxia (se >6 episódios/ano): Aciclovir 200mg 1 cp de 12/12h.

Incontinência urinária · CID R32

■ Casa — Prescrição — Casa

Oxibutinina 5mg

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas.

OU Imipramina 10mg

Tomar 1 comprimido ao dia.

■ Tratar constipação/DPOC/ICC/DM; evitar cafeína e álcool; fisioterapia pélvica.

Linfogranuloma venéreo · CID A55

■ Casa — Prescrição — Casa

Doxiciclina 100mg – 42 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 21 dias.

Mastite

■ Casa — Prescrição — Casa

Cefalexina 500mg

Tomar 1 comprimido de 6/6 horas por 10 a 14 dias.

OU Amoxicilina 500mg

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 10 a 14 dias.

Nefrolitíase / Cólica nefrética · CID N23

■ PS / Sala — Agora

Dieta zero. SF 0,9% 500ml EV.

Buscopan composto EV. Cetoprofeno EV.

Sem melhora: Tramadol 100mg + SF 0,9% 100ml EV lento; Bromoprida 10mg EV.

■ Casa — Uso oral

Buscopan composto

Tomar 1 comprimido de 6/6h se dor.

Cetoprofeno 100mg

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 5 dias.

Bromoprida 10mg

Tomar 1 comprimido 8/8h se náusea ou vômito.

Tansulosina 0,4mg

Tomar 1 comprimido 1x ao dia por 4–6 semanas.

■ Hemograma, ureia, creatinina, Urina I, TC sem contraste de abdome. Tansulosina para cálculos <1cm SEM infecção. Encaminhar urologista. Internação: febre, rim único, função renal limítrofe, gestante, imunossuprimidos.

Orquiepididimite • CID N45

■ PS / Sala — Agora

Ceftriaxona (250mg/2ml) 1 amp EV.

■ Casa — Jovem

Doxiciclina 100mg

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 10 dias.

Dipirona 500mg

Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6 horas se dor.

Ibuprofeno 600mg

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 3 dias.

■ Casa — Idoso

Levofloxacino 500mg

Tomar 1 comprimido de 24/24 horas por 10 dias.

Dipirona 500mg

Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6 horas se dor.

Ibuprofeno 600mg

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 3 dias.

■ Suspensório escrotal por 10 dias; evitar esforço físico; encaminhar urologista.

Pielonefrite • CID N11

■ PS / Sala — Na unidade

SF 250ml + 1 amp Dipirona.

■ Casa — Ambulatorial

Levofloxacino 750mg

Tomar 1 comprimido ao dia por 7 dias.

OU Ciprofloxacino 500mg

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 7 dias.

Dipirona 500mg

Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6 horas se dor.

Bromoprida 10mg

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas se náusea ou vômito.

■ Internação — Internação

SF 30-40ml/kg em 24h.

Dipirona 1g 6/6 horas se dor.

Bromoprida 10mg EV 8/8 horas se náusea ou vômito.

Ciprofloxacino 400mg EV 12/12 horas

OU Ceftriaxona 2g EV 24/24h.

■ Hemograma, ureia, creatinina, Urina I, urocultura, antibiograma, Na, K; se disponível USG vias urinárias e hemocultura. Ambulatorial: retornar em 48-72h para reavaliação. Internação se sepse, complicação, comorbidade significativa, não aceitação oral, não controle dos sintomas, gestação.

Sangramento uterino anormal • CID N93

■ PS / Sala — Sangramento agudo

Dieta branda. Ringer lactato 500-2000 ml EV correr rápido.

Monitorização. Glicemia capilar. Glicose hipertônica 50% 20ml EV se HGT <70. Repouso no leito.

Ácido tranexâmico 10mg/kg EV (dose máxima 600mg/dose) agora.

OU Ácido tranexâmico 1,5g VO de 8/8 horas por 5 dias.

■ Casa — Sangramento crônico

Levonorgestrel + etinilestradiol 0,15mg/0,03mg

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 7 dias. Depois, 1 comprimido por dia por 21 dias.

OU inserir DIU de levonorgestrel.

OU Ibuprofeno 600mg

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 5 dias.

OU Ácido tranexâmico 500mg

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 4 dias.

Sífilis • CID A53.9

■ Casa — Recente

Penicilina G benzatina 2.400.000 UI

Aplicar 1.200.000 UI IM em cada glúteo, dose única.

OU Doxiciclina 100mg

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 15 dias.

■ Casa — Tardia

Penicilina G benzatina 2.400.000 UI

Aplicar 1.200.000 UI IM em cada glúteo, 1x/semana por 3 semanas.

OU Doxiciclina 100mg

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 30 dias.

■ Solicitar teste rápido HIV, HBsAg/Anti-HBs/Anti-HBc, Anti-HCV, VDRL e FTA-Abs.

Tricomoniase · CID A59

■ Casa — Uso oral

Metronidazol 400mg
Tomar 5 comprimidos, dose única.
OU Metronidazol 250mg
Tomar 2 comprimidos de 12/12 horas por 7 dias.

■ Casa — Uso intravaginal

Metronidazol geleia vaginal 100mg/g — 1 bisnaga
Aplicar 1 aplicador cheio dentro da vagina, à noite ao deitar, por 7 noites.

■ Não beber álcool. Tratar parceria.

Vaginose bacteriana · CID N76

■ Casa — Uso oral

Metronidazol 250mg — 28 comprimidos
Tomar 2 comprimidos de 12/12h por 7 dias.

■ Casa — Uso vaginal

Metronidazol ginecológico 100mg/g
1 aplicador intravaginal por 5 noites.

■ Evitar roupas justas/sintéticas; não usar perfumes na vulva; evitar duchas; dormir sem calcinha; usar sabonete íntimo.

■ Pele

Abscesso cutâneo · CID L02

■ Casa — Prescrição — Casa

Cefalexina 500mg
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas por 7 dias.
Dipirona 500mg
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor.
Ibuprofeno 600mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 5 dias.

■ Compressa quente por 20 minutos 2x ao dia por 5 dias.

Alergia / Urticária · CID T78.4

■ Casa — Localizada

Cetoprofeno 100mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 5 dias.
Dexametasona creme 1mg/g
Aplicar nas lesões 2x ao dia por 10–14 dias.
OU Mometasona 1mg/g
Aplicar fina camada nas lesões 1x ao dia.
Hidroxizina 25mg
Tomar 1 comprimido de 8/8h por 3 dias.
OU Desloratadina 5mg
Tomar 1 comprimido 1x ao dia por 5 dias.

■ Casa — Extensa

Prednisona 20mg
Tomar 1 comprimido de 12/12h por 5–14 dias.
Hidroxizina 25mg
Tomar 1 comprimido de 8/8h.

■ Extensa/refratária: IM Fenegan.

Dermatite de contato · CID L24.9

■ Casa — Localizado

Dexametasona 0,1% creme
Aplicar nas lesões 2x ao dia por 10–14 dias.
OU (face e áreas de dobra)
Hidrocortisona 1% creme
Aplicar nas lesões 2x ao dia por 10–14 dias.
Hidroxizina 25mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas se prurido.
OU Dexclorfeniramina 2mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas se prurido.

■ Casa — Extenso

Prednisona 20mg
Tomar 0,5 mg/kg/dia por 5–14 dias.
Hidroxizina 25mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas se prurido.

Dermatite perioral · CID L71.0

■ Casa — Prescrição — Casa

Hidrocortisona 1% creme
Aplicar nas lesões 1–2x ao dia por 5–7 dias.
Moderados: Metronidazol 0,75% gel – aplicar nas lesões 2x por dia até melhora; OU Clindamicina 1% gel/loção
Extensos/não responsivos: Tetraciclina 250mg – 2 comprimidos 2x ao dia por 8–12 semanas; OU Doxiciclina 100mg

Disidrose · CID L30.1

■ Casa — Uso tópico

Propionato de clobetasol 0,05% creme ou pomada
Aplicar nas lesões 1x por dia, por 2–4 semanas ou até melhora.

■ Limitar lavagem de mãos (2–3x/dia); controlar estresse/temperaturas elevadas.

Erisipela / Celulite · CID A46 · L03

■ Casa — Ambulatorial

Amoxicilina + clavulanato 875/125mg
Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 10 dias.
OU Cefalexina 500mg
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas por 7 dias.
Dipirona 500mg
Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6 horas se dor.
Se não melhorar só com cefalexina, associar Clindamicina 300mg 1 cp de 6/6h ou 8/8h por 7 dias.

■ Internação — Internação

Cefazolina 1g EV de 8/8 horas por 7–14 dias
OU Ceftriaxona 1g EV de 12/12 horas por 7–14 dias
OU Clindamicina 600mg EV de 8/8 horas por 7–14 dias.
Dipirona 1g EV de 6/6 horas se dor. Bromoprida 10mg EV de 8/8 horas se náusea/vômito.

■ Compressa gelada 3x ao dia por 15 minutos. Se bolhas: Neomicina + bacitracina 20g — aplicar sobre lesão 2x ao dia. Cefalexina se >70kg: 1g de 6/6h.

Escabiose · CID B86

■ Casa — Uso oral

Ivermectina 6mg (200mcg/kg/dia – calcular por peso)
Tomar VO dose única. Repetir em 7 dias.
Loratadina 10mg
Tomar 1 comprimido 1x ao dia por 5–7 dias.
OU Hidroxizina 25mg
Tomar 1 comprimido à noite por 7 noites.

■ Casa — Uso tópico

Permetrina 5% loção ou creme – 1 frasco
Aplicar no corpo todo (adultos: poupar região cefálica; crianças e sarna crostosa: incluir couro cabeludo)
OU Enxofre precipitado 5% (manipular em vaselina) – 1 frasco
Aplicar no corpo todo (poupar região cefálica) por 3–4 noites seguidas.

■ Tratar todos do domicílio; trocar roupa de cama 1x/dia por 3 dias; estender roupas ao sol; manter unhas curtas.

Feridas / Curativos

■ Lavar com SF ou clorexidina degermante; aplicar pomada/curativo; gaze úmida; gaze seca + micropore. Pomada enzimática collagenase (tecido desvitalizado); ácidos graxos essenciais (prevenção/superficiais); hidrocoloides (não infectadas, exsudação leve-moderada); hidrogel (superficiais, remover crostas/fibrina); alginato de cálcio (sangrantes/altamente exsudativas); carvão ativado (fétidas/infectadas); sulfadiazina de prata (queimaduras/ação antibacteriana).

Foliculite · CID L73.9

■ Casa — Uso tópico

Sabonete antisséptico

Passar em regiões afetadas no banho, por 10 dias.

Mupirocina creme

Passar fina camada nas lesões, 2 a 3 vezes por dia, por 10 dias.

■ Casa — Uso oral

Dipirona 500mg

Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor.

Furúnculo / Carbúnculo · CID L02

■ Casa — Tópico

Ácido fusídico 2% creme

Aplicar na lesão 2x ao dia por 7 dias ou até melhora clínica.

OU Mupirocina 2% pomada

Aplicar na lesão 2x ao dia por 7 dias ou até melhora clínica.

■ Casa — Oral

Cefalexina 500mg

Tomar 1 comprimido de 6/6 horas por 7-14 dias.

■ Compressa quente 20 min 2x/dia por 5 dias; lavar com sabão de clorexidina. Repetição: Mupirocina 2% nas narinas 2x/dia por 5-10 dias + antisséptico (clorexidina/triclosan) em genitália, axilas, inguinal e inframamária por 7 dias.

Herpes simples · CID B00.9

■ Casa — Prescrição — Casa

Aciclovir 400mg

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas por 5 dias (ou 7 dias na primoinfecção).

Dipirona 500mg

Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor ou febre.

Herpes zoster · CID B02

■ Casa — Prescrição — Casa

Aciclovir 400mg

Tomar 2 comprimidos 5x ao dia por 7-10 dias.

Diclofenaco 50mg

Tomar 1 comprimido de 8/8 horas.

OU Paracetamol + codeína 500+7,5mg

Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor intensa.

Hidradenite supurativa · CID L73.2

■ Casa — Prescrição — Casa

Dipirona 500mg

Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6 horas se dor ou febre.

Clindamicina gel 1%

Aplicar na lesão de 12/12 horas até melhora clínica.

OU Ácido fusídico creme 2%

Aplicar na lesão de 8/8 horas até melhora clínica.

■ Encaminhar dermatologista.

Impetigo · CID L01

■ Casa — Uso tópico

Mupirocina 2% creme

Aplicar de 8/8 horas por 5-7 dias.

■ Casa — Extenso / falha tópica

Cefalexina 500mg

Tomar 1 comprimido de 6/6 horas por 7 dias.

OU Sulfametoxazol + trimetoprima 800+160mg

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas por 7-10 dias.

■ Lavagem com água e sabão ou sabonete antisséptico (triclosan, clorexidina).

Onicocriptose / Unha encravada · CID L60.0

■ Casa — Prescrição — Casa

Cefalexina 500mg
Tomar 1 comprimido VO de 6/6 horas por 7 dias.
Dipirona 500mg
Tomar 1 a 2 comprimidos VO de 6/6 horas se dor.
Ibuprofeno 300mg
Tomar 2 comprimidos VO de 8/8 horas, por 5 dias.

■ Não manipular a lesão; evitar calçados fechados/apertados; manter local limpo e seco.

Pediculose · CID B85.1

■ Casa — Uso tópico

Permetrina 1% shampoo
Aplicar no couro cabeludo, deixar agir 10 minutos e enxaguar. Repetir 3-5 vezes por semana.
OU Permetrina 5% loção
Aplicar no couro cabeludo à noite e lavar no dia seguinte. Por 3 noites seguidas; repetir após 7 dias.
Ácido acético 5%
Aplicar 10ml de ácido acético + 10ml de água fria antes de passar o pente fino.

■ Casa — Uso oral

Ivermectina 6mg
Tomar 200 mcg/kg, dose única. Repetir após 7 dias.

Queimadura · CID T30

■ PS / Sala — 3º grau

Dieta zero até estabilização.
Ringer lactato aquecido (4 × peso × SCQ) – metade em 8 horas, metade nas 16 horas seguintes.
Tramadol 100mg + SF 0,9% 100ml + Bromoprida 10mg
OU Morfina 10mg/ml + SG 9ml – fazer 3ml EV.
Sonda vesical – manter débito 0,5 ml/kg/hora.

■ Casa — 2º grau

Lavar com água corrente abundante; retirar objetos/roupas; limpeza com água e clorexidina degermante; curativo
Dipirona 500mg
Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6 horas se dor.
OU Paracetamol + codeína 500mg + 7,5mg
Tomar 1 comprimido de 6/6 horas se dor.
Hidroxizina 25mg
Tomar 1 comprimido de 8/8 horas se coceira.
Sulfadiazina de prata 1% (Dermazine/Pratazine)
Passar na lesão 1x ao dia.

■ Internar: queimadura 2º grau >10%, em face/mãos/pés/genitália, 3º grau, via aérea, elétrica.

Tínea capitis · CID B35.0

■ Casa — Uso oral

Griseofulvina (manipulado)
Tomar 500mg 1x ao dia ou de 12/12 horas, durante a refeição, por 5-7 dias.

Tínea corporis · CID B35.4

■ Casa — Uso tópico

Cetoconazol creme 2%
Aplicar na lesão 2x ao dia por 2-4 semanas.
OU Miconazol 2% creme/loção
Aplicar na lesão 2x ao dia por 2-4 semanas.

Tínea pedis · CID B35.3

■ Casa — Uso tópico

Cetoconazol creme 2%
Aplicar na lesão 2x ao dia por 4-6 semanas.
OU Miconazol 2% creme/loção
Aplicar na lesão 2x ao dia por 4-6 semanas.

■ Psiquiatria

Abstinência alcoólica · CID F10.3

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Diazepam 10mg – 1 comprimido a cada hora até melhora (máx 40mg/dia).
OU Lorazepam 2mg – 1 comprimido a cada hora até melhora (máx 10mg/dia).
E Tiamina 100–250mg EV/IM 1x/dia por 3 dias.
Se hipoglicemia (fazer tiamina antes): Glicose hipertônica 50% 4 amp EV.
Delirium tremens: Diazepam 5–10mg EV a cada 5–10 min (máx 20mg/dia).
Refratário: Fenobarbital 130–260mg EV a cada 15 min até melhora (máx 15 mg/kg/dia).

■ Hemograma, glicemia, ureia, creatinina, TGO, TGP, amilase, lipase.

■ Modelos / Bônus

Bulário rápido por sintoma

■ Modelo — Expectorante

Ambroxol xarope sem açúcar – 5ml 3x ao dia por 5 dias.
Acetilcisteína 600mg – 1x à noite por 5 noites (ou xarope 40mg/ml 15ml à noite; ou envelope 600mg/5g à noite).
Vick 44E xarope – 15ml de 6/6 horas.

■ Modelo — Tosse seca / antitussígeno

Seki xarope – 10ml 3x ao dia por 5 dias.
OU Cloperastina 3,54mg/ml – 10ml 3x ao dia por 5 dias.
Dropropizina 3mg/ml – 10ml 4x ao dia.

■ Modelo — Dor de garganta

Strepsils/Flogoral pastilha – 1 pastilha sempre que necessário.
Cloridrato de benzidamina pastilha – 1 pastilha VO de até 3/3 horas se dor de garganta.

■ Modelo — Resfriado (combinados)

Coristina D / Cimegripe / Resfenol (paracetamol, clorfeniramina, fenilefrina) – 1 cp de 6/6 horas.
Neolefrin (fenilefrina, carbinoxamina, paracetamol) – 1 cp de 8/8 horas.
Benegripe (dipirona, clorfeniramina, cafeína) – 3x ao dia.
Decongex Plus – 10 a 15ml 3x ao dia.

■ Modelo — AINE + protetor / pomada

Nivux – 1 cp de 12/12 horas por 3 dias.
Trok-N pomada – aplicar fina camada sobre lesão 1–2x por dia, por 7–10 dias.

Drenagem de abscesso

■ Modelo — Modelo

Separar material. Clorexidina alcoólico. Campo operatório.
Anestesia local (agulha marrom ou preta, mais finas).
Incisão pequena com lâmina 11 + Kelly para ampliar se necessário. Drenagem.
Colocar gaze dentro da loja se não houver drenagem espontânea.
Curativo: gaze + micropore.

Exames laboratoriais

■ Modelo — ISTs

HBSAg · Anti-HCV · Anti-HIV 1 e 2 · Anti-HBc total · Anti-HBs · anticorpos anti-gonococo IgM e IgG · Chlamydia

■ Modelo — Rotina

Hemograma · ureia · creatinina · Na · K · TGO · TGP · glicemia de jejum · triglicérides · colesterol total
>50 anos: sangue oculto nas fezes e mamografia. Mulheres >65a / homens >70a / fatores de risco: densitometria

Internação — prescrição padrão

■ Internação — Modelo

Dieta.
SF 0,9% 500ml EV, ACM.
Soro glicofisiológico 500ml EV, ACM.
Dipirona 1g 6/6h, se dor ou febre.
Tramal 100mg 6/6h, a critério médico.
Metoclopramida 8/8h, se náusea ou vômito.
Omeprazol 40mg VO/EV 1x ao dia.
Lactulose 667mg/ml 10ml de 12/12h, se constipação.
Enoxaparina 40mg SC 24/24h.
Controle dos sinais vitais 6/6h. Cabeceira elevada 30°.
Se DM ou NP0: dextro; insulina regular conforme dextro; glicose 50% se hipoglicemia.
Exames laboratoriais e de imagem. Se quadro infeccioso: urocultura e hemocultura.

Intubação orotraqueal (70 kg)

■ PS / Sala — Sequência rápida

MOV. Preparo: checar aspirador; materiais (laringoscópio 3 ou 4, tubo 7 ou 7,5,ambu, guedel, seringa 20ml)
Pré-oxigenação: máscara não reinalante ou bolsa-válvula 10 a 12 L/min por 3 a 5 minutos.
Analgesia: Fentanil (2mg/ml - 10ml): 3 a 4ml EV em bolus lento.
Hipnótico: Etomidato (10ml): 10ml EV (0,2 a 0,4 mg/kg) OU Quetamina (10ml): 3-4ml OU Propofol (20ml): 10-15ml EV
Bloqueador neuromuscular: Succinilcolina (10mg/ml): misturar o pó em 10ml SF, aspirar tudo (1 a 1,5mg/kg) C
IOT: checar ausculta.
Ventilador: Modo VCV, FiO2 100%, PEEP 6 a 10, FR 16, Tinsp 1,0, VC (4-6 ml/kg predito) ≈ 420 ml.
Sedação em BIC: Fentanil 4 amp + 500ml SF a 10 ml/h E Midazolam 4 amp + 500ml SF a 10 ml/h.

Prescrição de Ceftriaxona

■ Modelo — Modelo

Ceftriaxona 2g + 100ml SF 0,9% EV 1x ao dia – correr em 30 minutos.
Duração: ____ Data de início: ____

Templates — anamnese / EF / evolução

■ Modelo — Anamnese direcionada

QP: [queixa] há [tempo].
HDA: [início, evolução, intensidade, fatores de melhora/piora, sintomas associados].
Nega: [sinais de alarme da queixa].
APP: [comorbidades, medicações de uso, alergias].

■ Modelo — Exame físico direcionado

BEG, [afebril/febril], corado, hidratado, acianótico, anictérico.
SSVV: PA ____/____ | FC ____ | FR ____ | SatO2 ____% | Tax ____°C.
Direcionado: [achados relevantes à queixa].

■ Modelo — Exame físico completo

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Neuro: Glasgow 15, pupilas isofotorreagentes, sem déficits focais, sem sinais meníngeos.
ACV: 2 BRNF, sem sopros audíveis.
AR: MV+ bilateralmente, sem ruídos adventícios.
Abdome: flácido, indolor à palpação, RHA+, sem visceromegalias ou massas.
Membros: sem edema, sem dor à palpação, sem sinais de TVP, TEC <3s, pulsos amplos e simétricos.
Orofaringe sem alterações. Otoscopia: MT translúcida, sem abaulamentos.

■ Modelo — Evolução / conduta

[Diagnóstico / hipótese]
HDA: [resumo]. Nega [alarmes pesquisados].
EF: [SSVV + direcionado].
Conduta: Prescrevo sintomáticos na unidade. Prescrevo sintomáticos para domicílio.
Oriento sinais de alarme e retorno se necessário. Compreendeu. Alta em BEG.

■ Esqueleto universal: copiar e editar. Sempre documentar SSVV na alta, alarmes pesquisados e negativos, orientação de retorno compreendida.